

CRISIS CONVULSIVA PRIMER EPISODIO

J. Miranda Santiago, D. Pascual Carrascal, A. Hernando Asensio.

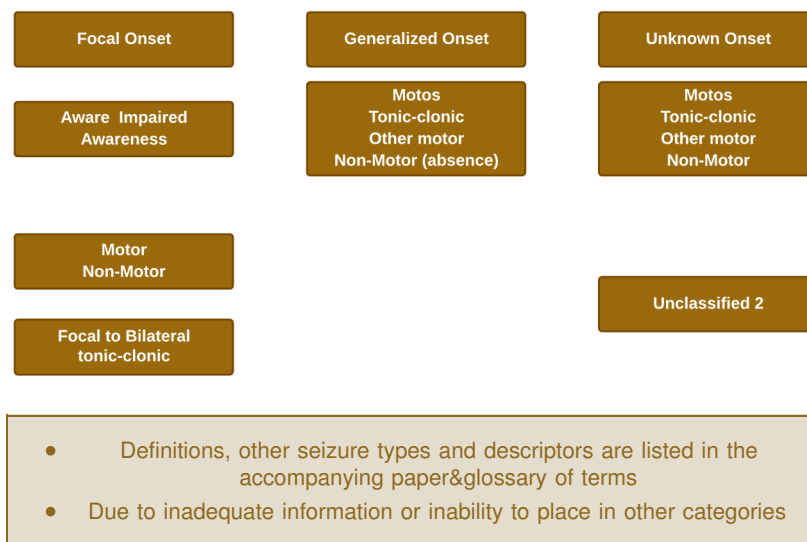
INTRODUCCIÓN

Conceptos

- **Epilepsia:** condición cerebral caracterizada por la predisposición permanente para generar crisis, y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, y sociales derivadas de esta condición (NO requiere la presencia de dos convulsiones para el diagnóstico).
- **Crisis epiléptica:** episodios autolimitados en los que se altera la función cerebral por una actividad anormal, excesiva y sincronizada de grupos neuronales corticales. Una primera crisis epiléptica representa el **3%** de las admisiones en urgencias. El **10%** de la población general va a tener una crisis a lo largo de su vida. La creación de un protocolo de cuidados en crisis epilépticas mejora la calidad de la atención, tanto en diagnóstico como tratamiento e información al paciente (individualizado en cada centro).
- Tipos de **crisis epilépticas:**
 - **Provocadas (o agudas sintomáticas):** asociadas a una agresión aguda del SNC (infección, infarto, trauma, hemorragia) o proceso sistémico (trastorno tóxico-metabólico o ingesta de alcohol u otras drogas)
 - **No provocadas (o remotas):** no se encuentra una causa aguda responsable.

Clasificación

ILAE 2017 Classification of Seizure Types Basic Versión 1



From Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2007 operational

Classification of seizure types. Epilepsia doi. 10.1111/epi. 13671

La clasificación internacional de las crisis epilépticas ha cambiado en **2017**; según su forma de inicio:

- **Crisis de inicio focal**: alteración limitada a un hemisferio.
 - Sin afectación del nivel de conciencia/ con afectación del nivel de conciencia.
 - Inicio motor o no motor (autonómica, cognitiva, emocional, sensorial).
 - Crisis focal **con extensión bilateral**, anteriormente conocidas como secundariamente generalizadas.
- **Crisis de inicio generalizado**: un inicio bilateral simétrico y sincrónico en ambos hemisferios.
 - **Motoras**: tónico-clónicas, tónicas, clónicas, atónicas, mioclónicas.
 - **No motoras (ausencias)**: cese de la actividad brusca con afectación de conciencia.
- **Crisis de inicio desconocido**: motoras, no motoras o inclasificables (si los datos clínicos obtenidos no permiten su categorización).

Etiología

- Infección del sistema nervioso central (SNC)
- Traumática
- Endocrino metabólica
- Tóxicos: alcohol, drogas, otros
- Tumoral
- Vascular: ictus, otros
- Desconocida

DIAGNÓSTICO

1º confirmar el diagnóstico de crisis epiléptica

Recabar toda la información posible tanto del **paciente** como de **familiares** y **testigos**:

importancia de informar a los acompañantes que deben acudir al centro de referencia, en cualquier caso.

- **Síntomas premonitorios** previos a la crisis.
 - **Circunstancias** de inicio de la crisis.
 - **Características** (motora o sensorial, etc), orden y secuencia.
 - **Afectación del nivel de conciencia** es clave; en ausencia de testigos la amnesia del episodio es un dato a favor.
 - **Episodios previos** de desconexiones del medio, o movimientos involuntarios (sobre todo en tónico-clónica).
 - **Recuperación** rápida o ha existido un período postcrítico.
- **Historia clínica extensa: antecedentes personales** perinatales, infecciones, traumas, ictus previos, o antecedente familiares de epilepsia.
- **Exploración general y neurológica completa**, buscando síntomas focales, y signos físicos de crisis (mordedura lingual, TCE, luxaciones o heridas).

2º la crisis es o no provocada

Para indicar un tratamiento específico si procede: **interrogar** sobre consumo de tóxicos, fármacos, alcohol, o enfermedades concomitantes (diabetes).

Diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden confundirse con crisis: síncope, pseudocrisis, accidente isquémico transitorio, auras migrañosas, amnesia global transitoria o trastornos del sueño.

3º pruebas complementarias

- **Analítica básica** con hemograma, coagulación (si toma anticoagulantes) y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, amilasa, bilirrubina, PCR.
- **Tóxicos en orina:** determinación de tóxicos según antecedentes. Pedir permiso oral o escrito a paciente o familiares, dejar constancia en historia clínica.
- **ECG** (buscar anomalías del ritmo cardíaco).
- En adultos con una **primera crisis** está siempre recomendado realizar una **prueba de imagen cerebral urgente** (TC o RM), en busca de lesiones estructurales. En paciente con **diagnóstico** previo de **epilepsia no será necesario** salvo si hay cambio en características de las crisis, focalidad neurológica en la exploración, status epiléptico, fiebre o TCE (sobre todo si está anticoagulado).
- **EEG:** su sensibilidad aumenta hasta un 77% si se realiza en las primeras 48 horas tras una crisis, de ahí la importancia de disponer de un EEG preferente/urgente (un resultado negativo no excluye el diagnóstico de crisis).

TRATAMIENTO

Generalmente cuando vemos al paciente la crisis ya ha cedido.

Si la convulsión **SE PROLONGA MÁS DE 2 MINUTOS** iniciar medidas generales y tratamiento con una ampolla de **diacepam iv** (10 mg diluida en 10 cc de suero fisiológico). En niños puede usarse la vía rectal, 10 mg de diacepam rectal en enema (Stesolid).

Medidas generales:

- Asegurar el **ABC** del paciente y las constantes vitales (TA, FC, SatO₂, Glucemia), saturación con pulsioxímetro (O₂ endonasal o VTM si SatO₂ < 94%) y vigilar la función respiratoria.
- Monitorizar cardíaca
- Vía venosa periférica

Tratamiento antiepiléptico: a continuación, iniciar tratamiento intravenoso con **fármaco antiepiléptico**:

- Ácido valproico (Depakine®) o
- Levetiracetam (Keppra®) en crisis generalizadas o crisis focales o con extensión bilateral o
- Fenitoína (Epanutin®) o
- Lacosamida (Vimpat®)

FAE(IV)	DOSIS INICIO	DOSIS MANTENIMIENTO	EFFECTOS SECUNDARIOS	PRECAUCIONES	INDICACIÓN
Levetiracetam	1500mg com 100cc SSFF en 5min (máximo x2 en 15 minutos)	500-1500 mg/12h com 100cc SSFF	Somnolencia, astenia (leves), mareo.	No interacciones	Crisis de inicio focal o generalizadas
Depakine	Infusión directa 400mg en 5 min, 20-30mg/kg com 100cc SSFF en 60min.	1 ampolla 400mg/6h o 1600mg en 24h en perfusión continua	Hipotensión, citopenias, bradicardia. Trombopenia.	Interacción con salicilatos. Aumenta niveles de BZD, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.	Crisis de inicio focal o generalizadas
Fenitoína	15-20mg/kg com 100cc SSFF en 30min.	6 mg/kg/24h.	Bloqueo AV y bradicardia sinusal (Hay que monitorizar ritmo cardíaco)	Interacción con casi todos los FAEs, furosemida, anticoagulantes orales, corticoides, amiodarona, teofilina	Crisis de inicio focal y con generalización secundaria
Lacosamida	200mg com 100cc SSFF en 15min (max 400mg)	200mg/12h.	Hipersensibilidad. Bloqueo AV 2º grado o completo (raro) (Hay que monitorizar ritmo)	No interacciones	Crisis de inicio focal y con generalización secundaria

- Una vez estabilizado el paciente es primordial identificar una **crisis provocada** para instaurar tratamiento específico, que será el de la causa.
 - En **pacientes alcohólicos**, donde pueden aparecer crisis de inicio generalizado tras 12 horas de abstinencia alcohólica: administrar Vitamina B1: **tiamina** (Benerva®) en dosis de 100-200 mg iv/im.
- El inicio de tratamiento antiepiléptico **no está recomendado de rutina** ante una primera crisis epiléptica aislada.
- Los adultos con crisis no provocadas deben ser siempre informados de que el **riesgo de recurrencia** es **mayor** en los **dos primeros años**, y que una lesión estructural, un EEG con anomalías epileptiformes o una crisis de inicio nocturno se asocian con un mayor riesgo de recurrencia.
- En estos casos la **decisión de iniciar un FAE** debe **individualizarse** de acuerdo con la opinión y las circunstancias de cada paciente.
- **Se recomienda la derivación a un neurólogo** para valoración en consulta de cara a la toma de decisiones.
- En cualquier caso, el paciente debe ser informado que tras una crisis epiléptica con afectación de conciencia:

- **No puede conducir u obtener el carnet de conducir durante 1 año**
- **No puede realizar** determinadas actividades de riesgo como **alpinismo o pesca submarina**.
- **Abstención del alcohol y otras drogas.**
- **Mantener un ritmo de sueño nocturno regular** para evitar recurrencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Saiz Díaz RA, de la Peña Mayor P. Crisis comiciales. En: Camacho Salas A. Urgencias en Neurología. 2º edición. Madrid: Ergon, 2013. p.57-78.
- Krumholz A, Wiebe S, et al. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. *Neurology**. 2015 Apr 21;84(16):1705-13.
- Fisher RS, Cross JH, et al. Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure types. *Epilepsia**. 2017 Apr 1;58(4):531-42.
- Martino T, Lalla A, et al. First-aid management of tonic-clonic seizures among healthcare personnel: A survey by the Apulian section of the Italian League Against Epilepsy. *Epilepsy Behav**. 2018 Mar 1;80:321-5.
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 5º edición. noviembre 2015. 3ª Reimpresión, julio 2019. Madrid: 2017 Editorial Médica Panamericana S.A. pag. 224-229.